CAC
Cuenta de Alto Costo

6

Cáncer de estómago

RESUMEN infográfico

Cáncer de estómago

6

2 de enero de 2024 al 1° de enero de 2025

Morbimortalidad del cáncer de estómago

Ocupó el **quinto lugar** entre los 11 tipos de cáncer priorizados y representó el 2,10 % del total de casos notificados al registro.

Se notificaron **2.706 casos nuevos invasivos** lo que corresponde a una PCNR estandarizada de 4,48 casos nuevos por cada 100.000 habitantes (IC 95 %: 4,31 - 4,65).

La mortalidad general estandarizada fue de **5,23 fallecimientos** por cada 100.000 habitantes (IC 95 %: 5,05 - 5,42).

El número total de casos nuevos, tumores registrados y fallecidos en el periodo fue de 2.721, 17.220 y 3.219, respectivamente.

Caracterización de los casos nuevos de cáncer de estómago

El 62,29 % de los casos nuevos correspondió a hombres.

La mediana de la edad fue de 65 años (RIC: 55 - 75).

La proporción de casos con estadificación TNM alcanzó el 75,89 %, la más alta observada en los últimos periodos de seguimiento.

Evaluación de la gestión del riesgo en los casos de cáncer de estómago

Para 2025, los tiempos hasta la confirmación diagnóstica aumentaron en comparación con el periodo anterior. En el régimen subsidiado, el promedio de días no alcanzó la meta de 30 días o menos y se amplió la brecha frente al contributivo.

Durante los últimos periodos, la tendencia de la detección temprana del cáncer de estómago se mantuvo por encima de la meta establecida (> 15 % de los casos nuevos en estadios I y II).

Descargar infografía

PCNR: proporción de casos nuevos reportados.
IC: intervalo de confianza.
RIC: rango intercuartílico.
CNR: casos nuevos reportados.

6. Cáncer de estómago

CIE10:C16 Y D002; CIE-O-3: C16 Y D002

6.1. Morbimortalidad del cáncer de estómago

Con 2.721 casos nuevos, el cáncer de estómago ocupó el quinto lugar entre los 11 tipos de cáncer priorizados y representó el 2,10 % del total de CNR, considerando las neoplasias *in situ* e invasivas. Asimismo, se registraron 17.220 tumores de este tipo de cáncer, de los cuales el 97,15 % (n= 16.730) correspondió a casos invasivos. Adicionalmente, se informaron 3.219 defunciones por todas las causas en personas con diagnóstico, entre las que se registraron 25 defunciones por todas las causas en casos *in situ*. En la **tabla 6.1** se presentan las principales medidas de morbimortalidad para cáncer de estómago. Para la estimación de estos indicadores se incluyeron exclusivamente los casos invasivos.

Tabla 6.1. Medidas de frecuencia del cáncer de estómago en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Medida	Casos[1]	Medida cruda[2,3]	Medida estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
PCNR	2.706	5,14	4,48	(4,31 - 4,65)
Prevalencia	16.730	31,80	27,35	(26,94 - 27,77)
Mortalidad[6]	3.194	6,07	5,23	(5,05 - 5,42)

[1] Incluye todos los casos de cáncer de estómago invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Informadas por 100.000 habitantes.
[3] La población de referencia corresponde a la proyectada por el DANE para el año 2024.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
[6] **Mortalidad general:** corresponde a los casos fallecidos por todas las causas, de la cohorte en seguimiento por la CAC.
PCNR: proporción de casos nuevos reportados; **IC:** intervalo de confianza.

6.1.1. PCNR de cáncer de estómago según la región y la entidad territorial

En el país, la PCNR estandarizada más elevada se presentó en Bogotá, D. C., con 1,79 veces más casos que la Central, mientras que la región con el menor valor fue la Caribe con 2,32 casos nuevos por 100.000 habitantes **(tabla 6.2).**

Por su parte, las entidades territoriales con las estimaciones más altas fueron Nariño y Huila con 8,75 y 7,55 casos, en ese orden; entre tanto, las más bajas se presentaron en Guaviare con 1,35, La Guajira con 1,52 y Sucre con 1,59. En los departamentos de Guainía, Vaupés, Vichada y San Andrés, Providencia y Santa Catalina no se reportaron casos nuevos con este tipo de cáncer.

Para conocer esta información con mayor desagregación, le invitamos a consultar HIGIA.

Tabla 6.2. PCNR del cáncer de estómago según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Región	CNR[1]	Denominador[2]	PCNR cruda[3]	PCNR estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Amazonía-Orinoquía	44	1.544.639	2,85	3,64	(2,64 - 4,87)
Bogotá, D. C.	701	7.918.660	8,85	7,39	(6,85 - 7,96)
Caribe	272	12.130.521	2,24	2,32	(2,05 - 2,61)
Central	647	12.486.760	5,18	4,12	(3,80 - 4,45)
Oriental	521	9.966.135	5,23	4,46	(4,08 - 4,86)
Pacífica	521	8.567.038	6,08	4,99	(4,56 - 5,44)
Nacional	**2.706**	**52.613.753**	**5,14**	**4,48**	**(4,31 - 4,65)**

[1] Incluye todos los casos nuevos de cáncer de estómago invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población proyectada por el DANE para el año 2024.
[3] La PCNR es informada por 100.000 habitantes.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
CNR: casos nuevos reportados; **PCNR:** proporción de casos nuevos reportados; **IC:** intervalo de confianza.

6.1.2. PCNR de cáncer de estómago según el régimen del aseguramiento y la entidad aseguradora

La PCNR estandarizada fue significativamente mayor en el régimen contributivo comparado con el subsidiado y el de excepción **(tabla 6.3).** Entre las entidades aseguradoras, las cifras más altas se observaron en la EAS016, la EPSS34 y la EPS046, con más de 8 casos nuevos por 100.000 afiliados. Por el contrario, los valores más bajos se presentaron en la EPSI03 y la ESS062 con menos de 1 caso nuevo. La EPS047 no reportó casos nuevos en el periodo.

La información completa de las EAPB está disponible en **HIGIA.**

Tabla 6.3. PCNR de cáncer de estómago según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Régimen	CNR[1]	Denominador[2]	PCNR cruda[3]	PCNR estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Contributivo	1.650	28.511.097	5,79	4,51	(4,30 - 4,74)
Subsidiado	964	20.558.122	4,69	3,80	(3,56 - 4,05)
Excepción	85	2.096.836	4,05	2,63	(2,07 - 3,31)
Especial	6	40.687	14,75	18,10	(1,74 - 63,38)
No asegurado	1	SD	SD	SD	SD
Planes voluntarios de salud	0	SD	SD	SD	SD

[1] Incluye todos los casos nuevos de cáncer de estómago invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población de la BDUA con corte al 30 de junio de 2024.
[3] La PCNR es Informada por 100.000 afiliados.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
En la población no asegurada y los planes voluntarios de salud, no se cuenta con la información para establecer el denominador, por lo cual solamente se presenta el número de CNR.
CNR: casos nuevos reportados; **PCNR:** proporción de casos nuevos reportados; **IC:** intervalo de confianza; **SD:** sin dato.

6.1.3. Prevalencia del cáncer de estómago según la región y la entidad territorial

De igual manera que en la PCNR, Bogotá, D. C., fue la región del país con la prevalencia estandarizada más alta, con una diferencia significativa con respecto al resto de las regiones. Por su parte, en la Caribe se evidenció el menor valor con menos de 10 casos por 100.000 habitantes **(tabla 6.4).** A su vez, los departamentos con las prevalencias estandarizadas más altas fueron Risaralda, Quindío y Norte de Santander, donde se presentaron

valores de 44,23, 42,85 y 42,11 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente. En contraste, Vaupés, La Guajira y Vichada obtuvieron las cifras más bajas con 3,99, 4,17 y 4,74, respectivamente.

Para conocer esta información con mayor desagregación, le invitamos a consultar HIGIA.

Tabla 6.4. Prevalencia del cáncer de estómago según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Región	Casos[1]	Denominador[2]	Prevalencia cruda[3]	Prevalencia estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Amazonía-Orinoquía	248	1.544.639	16,06	20,28	(17,82 - 22,97)
Bogotá, D. C.	4.142	7.918.660	52,31	43,44	(42,13 - 44,79)
Caribe	1.004	12.130.521	8,28	8,45	(7,93 - 8,99)
Central	5.209	12.486.760	41,72	32,42	(31,54 - 33,33)
Oriental	3.263	9.966.135	32,74	27,72	(26,77 - 28,69)
Pacífica	2.864	8.567.038	33,43	27,06	(26,07 - 28,08)
Nacional	**16.730**	**52.613.753**	**31,80**	**27,35**	**(26,94 - 27,77)**

[1] Incluye todos los casos de cáncer de estómago invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población proyectada por el DANE para el año 2024.
[3] La prevalencia es informada por 100.000 habitantes.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
IC: intervalo de confianza.

6.1.4. Prevalencia del cáncer de estómago según el régimen del aseguramiento y la entidad aseguradora

Para el 2025 el régimen contributivo registró una prevalencia estandarizada significativamente mayor a la del régimen subsidiado **(tabla 6.5).** Las cifras más altas se observaron en la EAS016, la EPS018 y la EPS008, con 50,78, 41,90 y 38,91 casos por 100.000 afiliados, respectivamente; mientras que la más baja se observó en la EPSI04 con 3,89. De manera similar a lo observado en los casos nuevos, la EPS047 tampoco reportó casos prevalentes de este tipo de tumor.

La información completa de las EAPB está disponible en HIGIA.

Tabla 6.5. Prevalencia del cáncer de estómago según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Régimen	Casos[1]	Denominador[2]	Prevalencia cruda[3]	Prevalencia estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Contributivo	11.026	28.511.097	38,67	29,75	(29,20 - 30,32)
Subsidiado	4.708	20.558.122	22,90	18,32	(17,79 - 18,86)
Excepción	724	2.096.836	34,53	20,58	(19,06 - 22,21)
Especial	36	40.687	88,48	35,09	(13,01 - 78,29)
No asegurado	24	SD	SD	SD	SD
Planes voluntarios de salud	5	SD	SD	SD	SD
Entidades liquidadas	207	SD	SD	SD	SD

[1] Incluye todos los casos de cáncer de estómago invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población de la BDUA con corte al 30 de junio de 2024.
[3] La prevalencia es informada por 100.000 afiliados.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
En la población no asegurada, los planes voluntarios de salud y en las entidades liquidadas, no se cuenta con la información para establecer el denominador, por lo cual solamente se presenta el número de casos notificados.
IC: intervalo de confianza; **SD:** sin dato.

6.1.5. Mortalidad en las personas con cáncer de estómago según la región y la entidad territorial

En la cohorte en seguimiento, la mortalidad general estandarizada más alta se observó en Bogotá, D. C., seguida de la región Pacífica. Mientras que la más baja se registró en la región Caribe, con 2,60 fallecimientos por 100.000 habitantes **(tabla 6.6).** Los departamentos de Nariño y Huila presentaron las PCNR más altas, y también registraron los mayores valores de mortalidad, con 9,25 y 8,08, respectivamente. En contraste, en Arauca, La Guajira y Magdalena se registraron dos o menos fallecimientos. Por otro lado, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vaupés y Vichada no registraron defunciones, lo cual es consistente con el reducido número de casos prevalentes reportados en estos departamentos (3, 1 y 4 casos, respectivamente).

Para conocer esta información con mayor desagregación, le invitamos a consultar HIGIA.

Tabla 6.6. Mortalidad general del cáncer de estómago según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Región	Muertes[1]	Denominador[2]	Mortalidad cruda[3]	Mortalidad estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Amazonía-Orinoquía	54	1.544.639	3,50	4,41	(3,31 - 5,75)
Bogotá, D. C.	752	7.918.660	9,50	7,90	(7,35 - 8,49)
Caribe	307	12.130.521	2,53	2,60	(2,31 - 2,91)
Central	897	12.486.760	7,18	5,62	(5,25 - 6,01)
Oriental	572	9.966.135	5,74	4,85	(4,46 - 5,27)
Pacífica	612	8.567.038	7,14	5,79	(5,33 - 6,27)
Nacional	**3.194**	**52.613.753**	**6,07**	**5,23**	**(5,05 - 5,42)**

[1] Incluye las muertes por todas las causas en la población con cáncer de estómago invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población proyectada por el DANE para el año 2024.
[3] La mortalidad es informada por 100.000 habitantes.
[4] Estandarización por la edad con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
IC: intervalo de confianza.

6.1.6. Mortalidad del cáncer de estómago según el régimen del aseguramiento y la entidad aseguradora

Entre los regímenes de aseguramiento, el contributivo presentó la mayor mortalidad general estandarizada con 5,19 defunciones por todas las causas por 100.000 afiliados **(tabla 6.7).** La mortalidad general más alta se evidenció en la EPS025 con 10,10 y la EPSS34 con 9,08 fallecidos; por el contrario, las cifras más bajas se presentaron en la EAS027 (1,31), la EPSI04 (1,34) y la EPSI01 (1,86). En este periodo, la EPS047 no reportó fallecidos y no tuvo casos prevalentes de cáncer de estómago.

La información completa de las EAPB está disponible en HIGIA.

Tabla 6.7. Mortalidad general del cáncer de estómago según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Régimen	Muertes[1]	Denominador[2]	Mortalidad cruda[3]	Mortalidad estandarizada[3,4]	IC 95 %[5]
Contributivo	1.922	28.511.097	6,74	5,19	(4,96 - 5,43)
Subsidiado	1.168	20.558.122	5,68	4,55	(4,29 - 4,83)
Excepción	69	2.096.836	3,29	2,04	(1,57 - 2,63)
No asegurado	1	SD	SD	SD	SD
Especial	0	40.687	SD	NA	NA
Planes voluntarios de salud	0	SD	SD	SD	SD
Entidades liquidadas	34	SD	SD	SD	SD

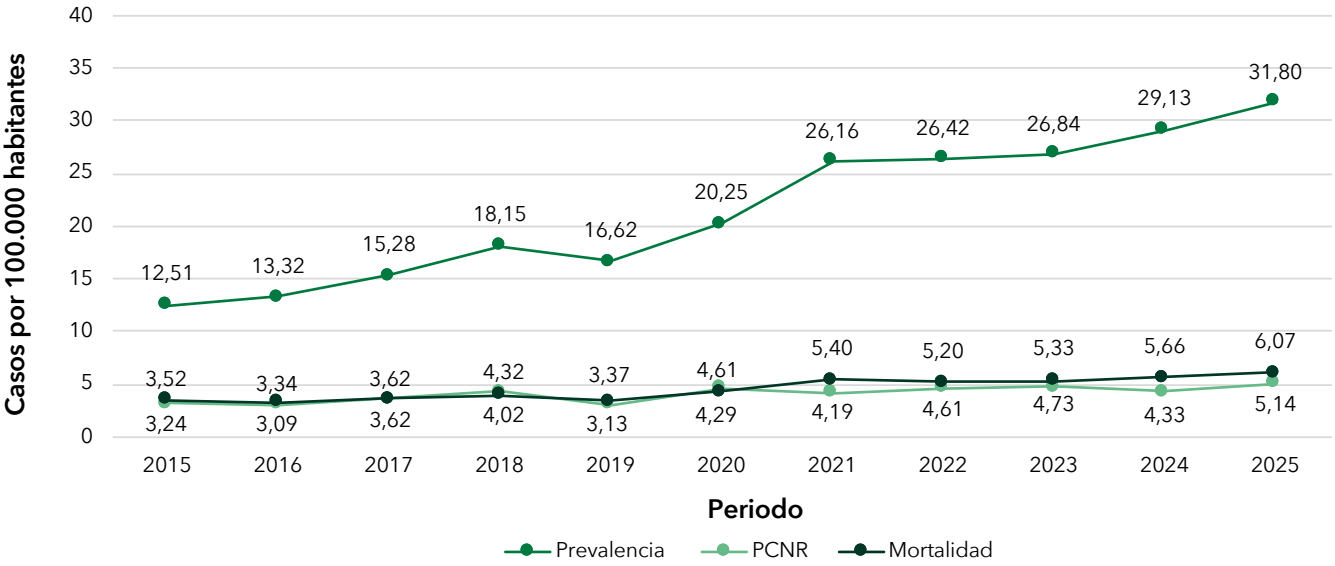
[1] Incluye las muertes por todas las causas en la población con cáncer de estómago invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
[2] Corresponde a la población de la BDUA con corte al 30 de junio de 2024.
[3] La mortalidad es informada por 100.000 afiliados.
[4] Estandarización por la edad calculada con método directo. La población de referencia correspondió a la estándar mundial por grupos quinquenales de edad, definida por la OMS.
[5] IC 95 % para las medidas estandarizadas.
En la población no asegurada, los planes voluntarios de salud y las entidades liquidadas, no se cuenta con la información para establecer el denominador, por lo cual solamente se presenta el número de fallecidos notificados.
IC: intervalo de confianza; **SD:** sin dato; **NA:** no aplica.

6.1.7. Evolución del registro de cáncer de estómago en el aseguramiento en Colombia

Las tres medidas de morbimortalidad del cáncer de estómago aumentaron en comparación con el periodo anterior. El incremento más marcado se presentó en la PCNR, con un aumento del 18,71 %. Asimismo, después de 11 periodos de seguimiento, el número de casos nuevos aumentó 1,59 veces, una tendencia similar a la observada en la cohorte de cáncer de colon y recto **(figura 6.1).**

Es de destacar que, en los últimos periodos, la mortalidad general ha superado el número de casos nuevos, lo que sugiere que una proporción importante de los pacientes continúa siendo diagnosticada en estadios avanzados. Esto implica menores posibilidades de tratamiento curativo, la rápida progresión clínica y en algunos casos el fallecimiento sin alcanzar la confirmación diagnóstica.

Figura 6.1. Tendencia de las medidas de frecuencia del cáncer de estómago en el marco del aseguramiento, Colombia 2015 - 2025



Incluye los casos de cáncer de estómago invasivo de la cohorte en seguimiento por la CAC.
Las medidas presentadas corresponden a valores crudos, reportados por 100.000 habitantes.
Mortalidad: corresponde al número de casos fallecidos por todas las causas de la cohorte en seguimiento por la CAC.
PCNR: proporción de casos nuevos reportados.
Descargar figura

6.2. Caracterización de los casos nuevos de cáncer de estómago

6.2.1. Características sociodemográficas de los casos nuevos de cáncer de estómago

A continuación, la **tabla 6.8** presenta la caracterización general de los casos nuevos de cáncer de estómago reportados en el periodo, de acuerdo con el régimen del aseguramiento. El 62,29 % correspondió a casos del sexo masculino, la mediana de la edad fue de 65 años y la mayoría de los casos diagnosticados residían en Bogotá, D. C., y la región Central. Entre los regímenes, se observaron diferencias en la concentración territorial; en el subsidiado, el mayor número de CN se concentró en las regiones Pacífica y Oriental; en el de excepción, en la región Oriental y Bogotá, D. C.; y en el contributivo, en Bogotá, D. C., y la Central.

De otra parte, para el 2025, seis nuevos casos del régimen especial presentaron una mediana de la edad de 59 años (RIC: 55 - 71), dos ubicados en la región Central y el resto en la Pacífica. Dentro de la población no asegurada se informó un caso de 71 años residente en la Oriental.

Tabla 6.8. Caracterización sociodemográfica de los casos nuevos de cáncer de estómago reportados según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Régimen del aseguramiento			Total[2]
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	
	n= 1.659	n= 969	n= 86	n= 2.721
	(60,97 %)	(35,61 %)	(3,16 %)	(100,00 %)
Sexo				
Femenino	622 (37,49)	364 (37,56)	36 (41,86)	1.026 (37,71)
Masculino	1.037 (62,51)	605 (62,44)	50 (58,14)	1.695 (62,29)
Edad	64 (54 - 73)	67 (57 - 76)	67 (58 - 77)	65 (55 - 75)
Etnia				
Ninguna	1.607 (96,87)	949 (97,94)	86 (100,00)	2.649 (97,35)
Negro	38 (2,29)	9 (0,93)	0 (0,00)	47 (1,73)
Indígena	1 (0,06)	11 (1,14)	0 (0,00)	12 (0,44)
Otro[3]	13 (0,78)	0 (0,00)	0 (0,00)	13 (0,48)
Región de residencia				
Amazonía-Orinoquía	10 (0,60)	34 (3,51)	0 (0,00)	44 (1,62)
Bogotá, D. C.	555 (33,45)	134 (13,83)	21 (24,42)	710 (26,09)
Caribe	97 (5,85)	172 (17,75)	4 (4,65)	273 (10,03)
Central	438 (26,40)	182 (18,78)	25 (29,07)	647 (23,78)
Oriental	310 (18,69)	183 (18,89)	30 (34,88)	524 (19,26)
Pacífica	249 (15,01)	264 (27,24)	6 (6,98)	523 (19,22)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %) para todas las variables, excepto la edad para la que se presenta le mediana (rango intercuartílico).
[2] Para los valores totales se tienen en cuenta un caso de la población no asegurada y seis en el régimen especial.
[3] Incluye población perteneciente a las etnias ROM (gitano), raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia y palenqueros de San Basilio.

6.2.2. Caracterización clínica de los casos nuevos reportados de cáncer de estómago

La **tabla 6.9** describe las características clínicas de los casos nuevos de este tipo de cáncer según su afiliación al sistema de salud. De acuerdo con la clasificación CIE-10, el 99,45 % de los CNR correspondió a tumores invasivos. También, después de cinco periodos consecutivos, el reporte de la estadificación en el marco del aseguramiento registró la mayor proporción de casos con estadificación, con un 75,89 %. Al considerar únicamente los casos estadificados, la mayoría fueron diagnosticados en estadios avanzados IV (46,05 %) y III (25,28 %), lo que indica una detección tardía para el 71,33 % de los CNR del periodo.

Asimismo, en comparación con los demás regímenes, el contributivo presentó una mayor proporción de casos con estadificación al momento del diagnóstico, en comparación con los demás regímenes. No obstante, la distribución de los casos diagnosticados en los estadios IV y III fue similar para todos los grupos de afiliación.

Tabla 6.9. Caracterización clínica de los casos nuevos de cáncer de estómago reportados según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Régimen del aseguramiento			Total[2]
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	
	n= 1.659	n= 969	n= 86	n= 2.721
	(60,97 %)	(35,61 %)	(3,16 %)	(100,00 %)
Extensión[3]				
In situ	9 (0,54)	5 (0,52)	1 (1,16)	15 (0,55)
Invasivo	1.650 (99,46)	964 (99,48)	85 (98,84)	2.706 (99,45)
Estadificación (sí)[4]	1.291 (77,82)	703 (72,55)	65 (75,58)	2.065 (75,89)
Estadio al diagnóstico[4,5]				
In situ	10 (0,77)	6 (0,85)	1 (1,54)	17 (0,82)
Estadio I	123 (9,53)	35 (4,98)	6 (9,23)	165 (7,99)
Estadio II	267 (20,68)	131 (18,63)	11 (16,92)	410 (19,85)
Estadio III	314 (24,32)	184 (26,17)	23 (35,38)	522 (25,28)
Estadio IV	577 (44,69)	347 (49,36)	24 (36,92)	951 (46,05)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %) para todas las variables.
[2] El tipo de tratamiento no es mutuamente excluyente: un mismo paciente pudo haber recibido más de un tipo de terapia.
[3] En este grupo se incluyen la quimioterapia y otras terapias sistémicas.
[4] Definida según la clasificación TNM.
[5] Incluye todos los casos nuevos de cáncer de estómago que fueron estadificados.

6.2.3. Caracterización del tratamiento en los casos nuevos de cáncer de estómago

Durante el periodo, el 65,31 % de los casos nuevos recibió terapias sistémicas, cirugía o radioterapia; entre estas modalidades, predominó la administración de quimioterapia e inmunoterapia, seguida de los procedimientos quirúrgicos. En la tabla 6.10 se muestra la distribución del tratamiento de acuerdo con el estadio clínico al diagnóstico.

La mayor proporción de casos que recibió algún tipo de tratamiento pertenecía al estadio III. La proporción de casos que fueron tratados con terapias sistémicas fue mayor a medida que los casos se encontraban en estadios avanzados; es decir que para estos tratamientos fue mayor el porcentaje en los estadios IV. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, fue mayor el número de casos nuevos intervenidos en el estadio III, seguido del II, mientras que la radioterapia fue administrada en el 8,67 % de los casos.

Tabla 6.10. Frecuencia del tratamiento prescrito en los casos nuevos de cáncer de estómago según el estadio clínico en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

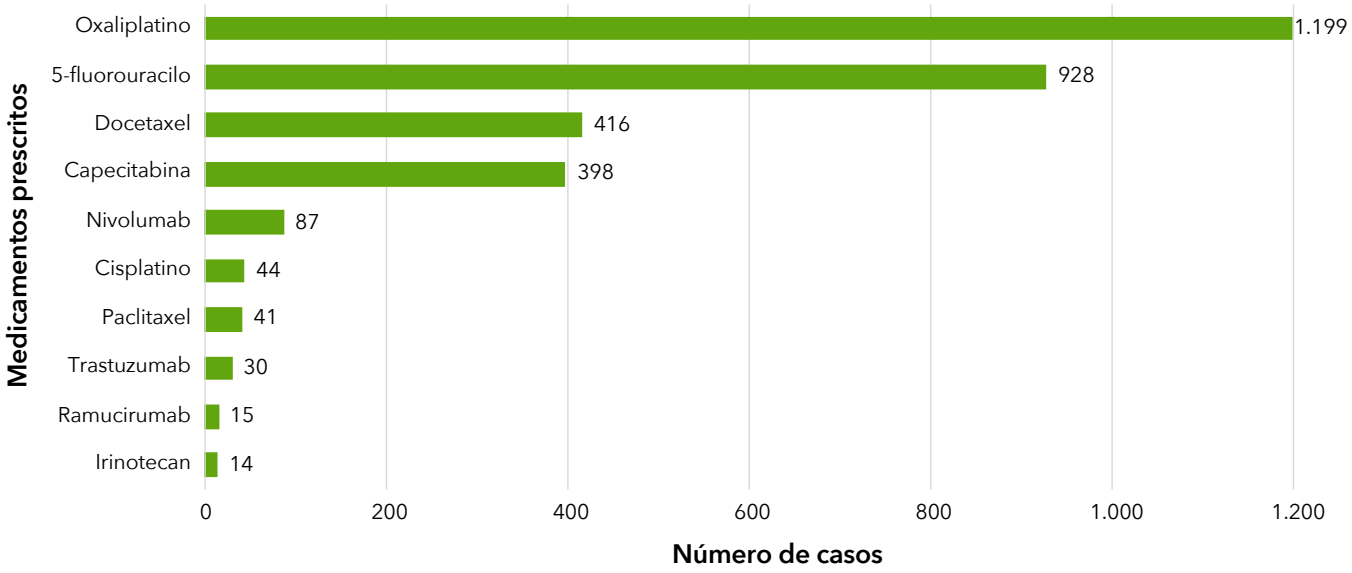
Variables[1]	Estadio al diagnóstico						Total
	In situ	Estadio I	Estadio II	Estadio III	Estadio IV	Desconocido	
	n= 17	n= 165	n= 410	n= 522	n= 951	n= 656	n= 2.721
	(0,63 %)	(6,06 %)	(15,07 %)	(19,18 %)	(34,95 %)	(24,11 %)	(100,00 %)
Casos que recibieron algún tratamiento	5 (29,41)	131 (79,39)	324 (79,02)	455 (87,16)	636 (66,88)	226 (34,45)	1.777 (65,31)
Tipo de tratamiento prescrito[2]							
Terapia sistémica[3]	0 (0,00)	51 (38,93)	241 (74,38)	370 (81,32)	564 (88,68)	127 (56,19)	1.353 (76,14)
Cirugía	5 (100,00)	112 (85,50)	208 (64,20)	304 (66,81)	154 (24,21)	128 (56,64)	911 (51,27)
Radioterapia	0 (0,00)	5 (3,82)	25 (7,72)	50 (10,99)	64 (10,06)	10 (4,42)	154 (8,67)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %) para todas las variables.
[2] El tipo de tratamiento no es mutuamente excluyente: un mismo paciente pudo haber recibido más de un tipo de terapia.
[3] En este grupo se incluyen la quimioterapia y otras terapias sistémicas.

Adicionalmente, un total de 944 casos nuevos no reportó ningún tratamiento curativo. De estos, el 40,47 % fue diagnosticado en estadios avanzados, mientras que en el 45,55 % el estadio era desconocido. Además, el 23,94 % tenía confirmación del diagnóstico en los tres meses previos a la fecha de corte. No obstante, la totalidad de estos casos reportó valoración por cuidados paliativos.

La **figura 6.2** describe los medicamentos prescritos con mayor frecuencia a las personas con nuevo diagnóstico de cáncer de estómago. Es importante tener en cuenta que los datos presentados corresponden a frecuencias absolutas, es decir, no se tiene en cuenta el uso concomitante de uno o más fármacos. Aún así, se puede apreciar que los esquemas con oxaliplatino y 5-fluorouracilo tales como el FLO y el FLOT presentaron una mayor indicación como primera línea de tratamiento en los casos nuevos, mientras que una menor frecuencia de indicación se presentó en medicamentos como el nivolumab, el paclitaxel y el irinotecan, los cuales hacen parte del manejo de los casos en estadios avanzados. En cuanto a las terapias biológicas, se mantiene una frecuencia en el reporte similar a la del periodo anterior con trastuzumab y ramucirumab, en ese orden.

Figura 6.2. Distribución de los medicamentos prescritos con mayor frecuencia en los casos nuevos de cáncer de estómago en el marco del aseguramiento, Colombia 2025



Incluye cáncer *in situ* e invasivo.

Descargar figura

6.3. Caracterización de los casos prevalentes de cáncer de estómago

La **tabla 6.11** presenta una caracterización general de los casos prevalentes de cáncer de estómago reportados en el periodo según el régimen del aseguramiento. Para el 2025, un total de 17.011 casos de cáncer de estómago (*in situ* e invasivo) tuvieron seguimiento en el país, la mayoría estaban afiliados al contributivo, un poco más de la mitad correspondió a casos del sexo masculino, la mediana de la edad fue de 67 años (RIC: 57 - 76) y el 55,35 % residía en la región Central o en Bogotá, D. C. Por su parte, la mayor proporción de casos en la población indígena se encontraban afiliados al subsidiado.

En la población no asegurada se informaron 25 casos, con una mediana de la edad de 62 años (RIC: 40 - 72); de estos, 18 eran hombres y el 44,00 % residía en la región Pacífica. En los planes voluntarios de salud se reportaron cinco casos, de los cuales dos eran del sexo femenino, tres residían en Bogotá, D. C., y la mediana de la edad fue de 77 años (RIC: 70 - 83).

Tabla 6.11. Caracterización sociodemográfica de los casos prevalentes de cáncer de estómago según el régimen del aseguramiento, Colombia 2025

Variables[1]	Régimen del aseguramiento				Total[2,3]
	Contributivo	Subsidiado	Excepción	Especial	
	n= 11.416	n= 4.787	n= 742	n= 36	n= 17.011
	(67,11 %)	(28,14 %)	(4,36 %)	(0,21 %)	(100,00 %)
Sexo					
Femenino	5.189 (45,45)	2.122 (44,33)	306 (41,24)	15 (41,67)	7.641 (44,92)
Masculino	6.227 (54,55)	2.665 (55,67)	436 (58,76)	21 (58,33)	9.370 (55,08)
Edad	67 (57 - 76)	67 (58 - 76)	70 (62 - 78)	74 (62 - 86)	67 (57 - 76)
Etnia					
Ninguna	11.276 (98,77)	4.586 (95,80)	728 (98,11)	36 (100,00)	16.656 (97,91)
Negro	110 (0,96)	61 (1,27)	13 (1,75)	0 (0,00)	184 (1,08)
Indígena	12 (0,11)	135 (2,82)	0 (0,00)	0 (0,00)	147 (0,86)
Otro[4]	18 (0,16)	5 (0,10)	1 (0,13)	0 (0,00)	24 (0,14)
Región de residencia					
Amazonía-Orinoquía	83 (0,73)	161 (3,36)	7 (0,94)	0 (0,00)	251 (1,48)
Bogotá, D. C.	3.379 (29,60)	596 (12,45)	192 (25,88)	5 (13,89)	4.182 (24,58)
Caribe	491 (4,30)	570 (11,91)	46 (6,20)	0 (0,00)	1.111 (6,53)
Central	3.592 (31,46)	1.373 (28,68)	252 (33,96)	14 (38,89)	5.235 (30,77)
Oriental	2.244 (19,66)	884 (18,47)	175 (23,58)	1 (2,78)	3.315 (19,49)
Pacífica	1.627 (14,25)	1.203 (25,13)	70 (9,43)	16 (44,44)	2.917 (17,15)

[1] Los valores reportados corresponden a frecuencias absolutas y relativas (n, %) para todas las variables, excepto la edad para la que se presenta la mediana (rango intercuartílico).
[2] Para los valores totales se tienen en cuenta 25 casos reportados como población no asegurada y cinco casos de los planes voluntarios de salud.
[3] No se incluyen los datos de 209 casos prevalentes que no se reportaron en el periodo actual o que pertenecen a entidades liquidadas.
[4] Incluye población perteneciente a las etnias ROM (gitano), raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia, y palenquero de San Basilio.

6.4. Indicadores de gestión del riesgo en cáncer de estómago

Los siguientes son los indicadores prioritarios para la medición, la evaluación y el monitoreo de la gestión del riesgo por parte de los aseguradores y de los prestadores en las personas con cáncer de estómago en Colombia (1):

1. Oportunidad de diagnóstico (promedio del tiempo entre la consulta o remisión para diagnóstico y el reporte histopatológico).
2. Proporción de pacientes con cáncer gástrico clasificado *in situ*.

3. Proporción de casos nuevos identificados en estadios tempranos.
4. Proporción de pacientes con estadificación por TNM.
5. Oportunidad de tratamiento (promedio del tiempo entre el diagnóstico y el primer tratamiento).
6. Oportunidad entre la neoadyuvancia y la cirugía curativa (promedio de días).
7. Oportunidad entre la cirugía y el inicio de adyuvancia (promedio de días).
8. Proporción de pacientes estadio 0 a III sometidos a cirugía como tratamiento curativo indicador.
9. Proporción de pacientes con evaluación por grupo interdisciplinario para definición del tratamiento.
10. Valoración por cuidados paliativos (CNR, estadio invasivo).
11. Calidad de la cirugía.
12. Proporción de pacientes con valoración por nutrición.
13. Proporción de pacientes posquirúrgicos con soporte nutricional.
14. Supervivencia a 2 y 5 años.
15. Tasa de mortalidad general.
16. Mortalidad operatoria.

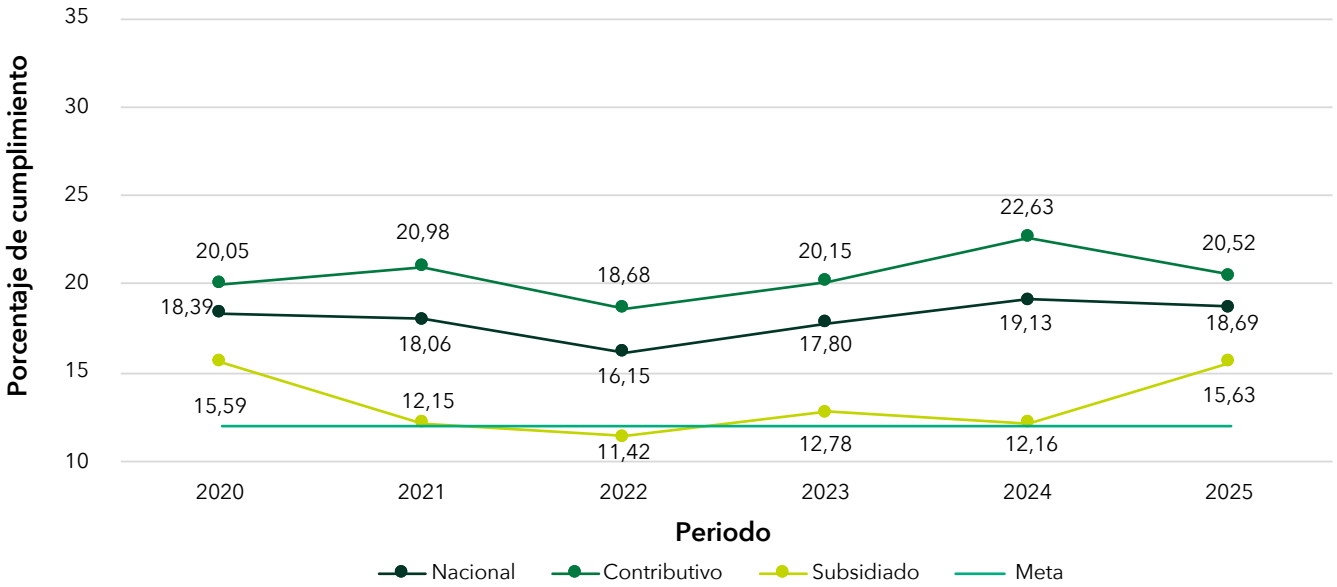
Cabe destacar que el indicador 14 se estimó recientemente y se presentó en el informe especial "Resultados de supervivencia global en las personas atendidas en el marco del sistema de salud colombiano y notificadas a la Cuenta de Alto Costo 2014-2022" (2). Por otra parte, los resultados del indicador 15 para este tipo de cáncer son abordados al inicio del capítulo, en la sección de morbimortalidad.



Puede consultar los datos de la gestión del riesgo con una mayor desagregación ingresando a HIGIA.

Durante los últimos periodos, la tendencia de la detección temprana del cáncer de estómago se mantuvo por encima de la meta establecida (> 15 % de los casos nuevos en los estadios I y II). Los resultados de este indicador en el régimen contributivo han sido superiores a los del subsidiado, a pesar de la disminución del 9,32 % que se presentó para el 2025. Por su parte en el subsidiado, luego de cuatro periodos consecutivos, el porcentaje presentó un aumento, lo que redujo la brecha entre ambos regímenes. Sin embargo, estos resultados reflejan que más de la mitad de los casos continuó diagnosticándose en fases avanzadas, por lo que las dificultades persistentes para la detección oportuna de esta neoplasia; esto en un escenario caracterizado por síntomas iniciales inespecíficos, manejo clínico inicial poco orientado al diagnóstico de cáncer, falta de programas estructurados de tamización y barreras en el acceso al diagnóstico (3).

Figura 6.3. Tendencia de la proporción de los casos nuevos en estadios tempranos en el momento del diagnóstico en cáncer de estómago en el marco del aseguramiento, Colombia 2020 - 2025

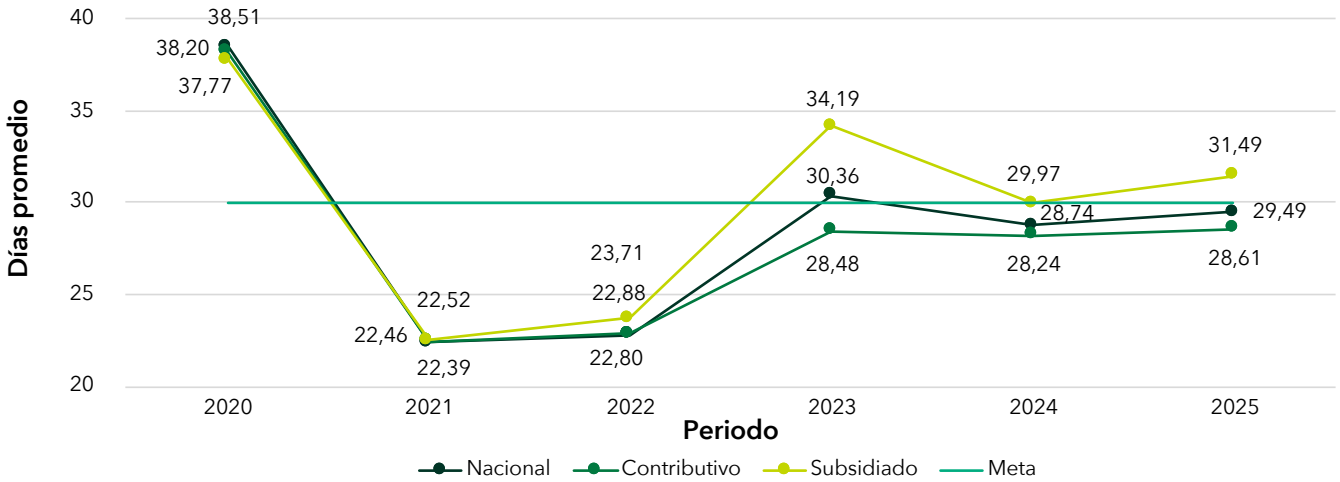


Detección temprana: incluye estadios I a IIA.

Descargar figura

Para 2025, los tiempos hasta la confirmación diagnóstica aumentaron en comparación con el periodo anterior. En el régimen subsidiado, el promedio de días no alcanzó la meta de 30 días o menos y se amplió la brecha frente al contributivo, lo que evidencia un deterioro en la oportunidad diagnóstica para esta población.

Figura 6.4. Tendencia de la oportunidad de la confirmación diagnóstica de los casos nuevos de cáncer de estómago en el marco del aseguramiento, Colombia 2020 – 2025

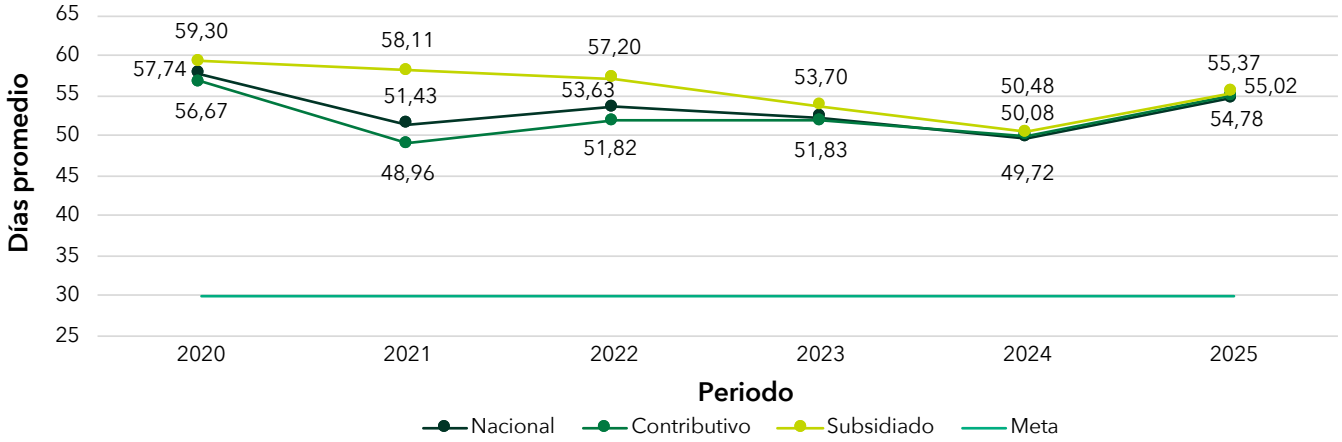


Incluye cáncer *in situ* e invasivo.
Tiempo transcurrido desde la consulta o la remisión hasta la confirmación diagnóstica.
La media (desviación estándar) para la oportunidad del diagnóstico en el 2025 fue: de 29,49 días (± 45,24) en la medición nacional, de 28,61 días (± 36,82) en el régimen contributivo y de 31,49 días (± 58,83) en el subsidiado.
La mediana (rango intercuartílico) para la oportunidad del diagnóstico en el 2025 fue: de 16 días (RIC: 8 - 34) en la medición nacional, de 17 días (RIC: 9 - 35) en el contributivo y de 15 días (RIC: 8 - 32) en el subsidiado.

Descargar figura

En cuanto al inicio del tratamiento, en el último periodo se interrumpió la tendencia de reducción progresiva de los tiempos observada en periodos previos. Tanto en el cálculo nacional como entre los regímenes se registró un aumento cercano a los cinco días. No obstante, se resalta que desde 2024 los resultados de este indicador no han mostrado diferencias significativas entre el régimen contributivo y el subsidiado.

Figura 6.5. Tendencia de la oportunidad del inicio del tratamiento de los casos nuevos de cáncer de estómago en el marco del aseguramiento, Colombia 2020 – 2025



Incluye cáncer *in situ* e invasivo.
Tiempo entre el diagnóstico histológico y el primer tratamiento.
La media (desviación estándar) para la oportunidad del tratamiento en el 2025 fue: de 54,78 días (± 47,80) en la medición nacional, de 55,02 días (± 46,64) en el régimen contributivo y de 55,37 días (± 50,64) en el subsidiado.
La mediana (rango intercuartílico) para la oportunidad del tratamiento en el 2025 fue: de 42 días (RIC: 21 - 76) en la medición nacional, de 43 días (RIC: 23 - 73) en el régimen contributivo y de 37 días (RIC: 17 - 84) en el subsidiado.

Descargar figura

A continuación, la **tabla 6.12** presenta los resultados de los indicadores de gestión del riesgo del cáncer de estómago según la región de residencia. En todo el territorio nacional se observó un aumento en el promedio de días para la confirmación del diagnóstico; este comportamiento tuvo un mayor impacto en la región Amazonía-Orinoquía, donde el resultado pasó de un alto cumplimiento de la meta a un nivel de desempeño intermedio. De igual forma, en la detección temprana, esta misma región refleja dificultades, al presentar la menor proporción de casos nuevos diagnosticados en estadios I y II. En contraste, la estadificación de los CN se mantuvo relativamente similar entre las diferentes entidades territoriales.

En cuanto al inicio del primer tratamiento, los tiempos más prolongados se observaron en las regiones Oriental y Pacífica. Puntualmente, la realización de los procedimientos quirúrgicos después de la terapia neoadyuvante superó la recomendación de 12 semanas y los mayores retrasos se presentaron en las regiones Caribe y Central. En contraste, el inicio de las terapias sistémicas posterior a la cirugía se mantuvo por debajo de los 84 días en todas las regiones del país. Esta heterogeneidad en las oportunidades de atención refleja una asistencia fragmentada y la presencia de posibles barreras para la realización oportuna de los procedimientos quirúrgicos, lo cual es consistente con el bajo porcentaje de casos con seguimiento multimodal, el cual fue inferior al 10 %.

Tabla 6.12. Indicadores de gestión del riesgo en cáncer de estómago según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025

Número		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Código[1]		EST_01	EST_02	EST_03	EST_04	EST_05	EST_06	EST_07
Semaforización		< 30 días	> 3,4 %	> 12 %	> 90 %	< 30 días	≤ 84 días (≤ 12 semanas)	≤ 84 días (≤ 12 semanas)
		30 a < 60 días	1,8 a 3,4 %	> 8 a 12 %	> 60 a 90%	30 a < 60 días		
		≥ 60 días	< 1,8 %	≤ 8 %	≤ 60 %	≥ 60 días	> 84 días (> 12 semanas)	> 84 días (> 12 semanas)
Región	Amazonía-Orinoquía	54,79	2,94	6,06	77,27	57,39	136,00	56,67
	Bogotá, D. C.	32,54	1,84	24,39	76,16	56,07	95,46	58,18
	Caribe	34,29	0,50	13,00	73,63	40,99	111,00	72,96
	Central	26,24	0,00	20,22	83,31	48,07	110,77	56,20
	Oriental	30,92	0,79	20,00	72,00	62,33	91,53	74,33
	Pacífica	23,33	0,50	11,62	75,81	61,75	109,44	64,14
Nacional		**29,49**	**0,81**	**18,69**	**76,75**	**54,78**	**102,81**	**62,98**

Tabla 6.12. Indicadores de gestión del riesgo en cáncer de estómago según la región de residencia en el marco del aseguramiento, Colombia 2025 (continuación)

Número		8.	9.	10.	11.	12.	13.	16.
Código[1]		EST_08	EST_09	EST_10	EST_11	EST_12	EST_13	EST_16
Semaforización		> 90 %	Por definir	Por definir	Por definir	> 90 %	> 90 %	≤ 20 %
		> 60 a 90 %				> 60 a 90 %	> 60 a 90 %	
		≤ 60 %				≤ 60 %	≤ 60 %	> 20 %
Región	Amazonía-Orinoquía	35,71	6,82	51,52	55,56	34,09	0,00	0,00
	Bogotá, D. C.	48,31	3,23	57,79	33,01	49,93	13,40	4,60
	Caribe	34,78	3,66	54,50	30,36	54,58	28,57	10,20
	Central	60,89	3,86	54,73	50,23	52,86	19,91	1,93
	Oriental	43,48	4,76	40,00	47,02	39,24	13,25	3,20
	Pacífica	52,67	2,48	54,04	41,72	47,05	32,45	2,24
Nacional		**50,18**	**3,63**	**52,65**	**42,16**	**48,22**	**19,70**	**3,45**

[1] Código del indicador en HIGIA.

Referencias bibliográficas

1. Cuenta de Alto Costo. Consenso basado en evidencia. Indicadores de gestión del riesgo en pacientes con cáncer gástrico y cáncer de colon y recto en Colombia [en línea]. 2017. Disponible en: https://cuentadealtocosto.org/publicaciones/consenso-basado-en-evidencia-indicadores-de-gestion-del-riesgo-en-pacientes-con-cancer-gastrico-y-cancer-de-colon-y-recto-en-colombia/

2. Cuenta de Alto Costo (CAC), Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo. Informe especial: Resultados de supervivencia global en las personas atendidas en el marco del sistema de salud colombiano y notificadas a la Cuenta de Alto Costo, 2014-2022; Bogotá, D. C. 2025. Disponible en: https://cuentadealtocosto.org/publicaciones/informe-de-supervivencia-2014-2022/

3. Tajul Islam Mamun, Sabrina Younus, Md. Hashibur Rahman, Gastric cancer—Epidemiology, modifiable and non-modifiable risk factors, challenges and opportunities: An updated review, Cancer Treatment and Research Communications, Volume 41, 2024, 100845, ISSN 2468-2942, https://doi.org/10.1016/j.ctarc.2024.100845

CAC
Cuenta de Alto Costo

7

Cáncer de pulmón